

ONGEVALLENVERZEKERING · FICTIEF VOORBEELD

Orthopedische expertise ongevallenverzekering

Vraagstelling van de verzekeraar · blijvende invaliditeit

ZAAKNUMMER

2025-KME-01317

BETROKKENE

PERSOON-1

SPECIALISME

Orthopedisch

ONDERZOEK

T+24m

FICTIEF VOORBEELD · GEEN PERSOONSgegevens

KINETICMEDICAL.NL

KERNBEVINDINGEN

De conclusies van de arts, vooraf samengevat

DIAGNOSE

Lichte bewegingsbeperking en belastingspijn van de rechter knie na een tibiaplateaufractuur

RELATIE MET HET ONGEVAL Medisch aannemelijk Geen aanwijzingen voor een andere oorzaak	EINDSITUATIE Bereikt Per T+24m	VOORAFBESTAAND Geen Geen knieklachten of afwijkingen bekend	BLIJVENDE INVALIDITEIT 19% Functieverlies rechterbeen, AMA Guides 6e druk
DOSSIER 8 van 9 stukken 1 hiaat, niet bepalend			

AANGELEVERDE STUKKEN

8 van 9 stukken aanwezig

 SEH-verslag met CT	 Operatieverslag	 Ontslagbrief	 Poliklinische brieven orthopedie	 Fysiotherapie intake en tussenrapportage
 Röntgenverslag controle	 Huisartsjournaal	 AAOS-vragenlijst	 Fysiotherapie eindverslag ONTBREEKT	



ONDERDEEL

Opdracht en polis

Gegevens verzekeraar en betrokkene

[DOSSIERORDENING](#)

Verzekeraar	OPDRACHTGEVER
Betrokkene	PERSOON-1
Geboortedatum	GEBORTE DATUM
Beroep	Monteur installatietechniek
Ongeval	T±0: val van een trap tijdens werkzaamheden
Datum onderzoek	T+24m

Kader van dit rapport

[DOSSIERORDENING](#)

Soort expertise	Ongevallenverzekering: een uitkering op grond van de eigen polis; geen aansprakelijkheid
Kernvraag	Hoeveel blijvend functieverlies is er, gemeten volgens de maatstaf van de polis?
Doel van de uitkomst	Basis voor een vaste uitkering: percentage maal verzekerd bedrag
Partijen	Verzekerde en de eigen verzekeraar; schuld speelt geen rol
Vraagstelling	Van de verzekeraar, gebaseerd op de polis
Invalideitspercentage	De hoofdvraag
Richtlijn rapportage	NVMSR 2024

Polis en opdracht kader

[DOSSIERORDENING](#)

Soort verzekering	Collectieve ongevallenverzekering via de werkgever; geen letselschadezaak
Polisnummer	POLISNUMMER
Polisvoorwaarden	POLISVERSIE, artikel 7 (blijvende invaliditeit)
Begrip ongeval	Zoals omschreven in artikel 1 van de polis
Dekking als uitgangspunt	Ja; de verzekeraar heeft het voorval als gedekt ongeval aanvaard (opdrachtbrief)

Invaliditeitsmaatstaf	AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 6e druk, uitgedrukt als percentage functieverlies van het betrokken lichaamsdeel
Maximum voor dit lichaamsdeel	70% voor volledig functieverlies van een been, volgens de polis
Peildatum en termijn	Vaststelling blijvende invaliditeit volgens de polis uiterlijk twee jaar na het ongeval
Voorafbestaande invaliditeit	Volgens de polis in mindering te brengen
Maatstaf	De specialist past uitsluitend de door de verzekeraar aangewezen medische maatstaf toe. De uitleg en toepassing van de polisvoorwaarden blijft voorbehouden aan de verzekeraar. Bij verschil tussen dit rapport en de polis prevaleert de polis.
Rol van de deskundige	De deskundige beoordeelt uitsluitend de medische gevolgen en eventuele functionele invaliditeit. De uitleg van polisvoorwaarden en de beslissing over dekking zijn aan de verzekeraar.

Vragen van de verzekeraar

DOSSIERORDENING

Zoals gesteld in de opdrachtbrief.

- 1 Wat is de aard van het letsel en de huidige diagnose?
- 2 Zijn de huidige afwijkingen medisch het gevolg van het ongeval?
- 3 Bestonden er vóór het ongeval klachten, afwijkingen of functieverlies aan het betrokken lichaamsdeel?
- 4 Is er sprake van een medische eindsituatie? Zo nee, wanneer wordt die verwacht?
- 5 Wat is de blijvende invaliditeit volgens de maatstaf in de polis, en welk deel daarvan bestond al vóór het ongeval?
- 6 Heeft u overige opmerkingen?

Samenvatting medische informatie

DOSSIERORDENING



T±0 ○ SEH: laterale tibiaplateaufractuur rechts, split-depressie; CT: impressie 6 mm (bron 1, p. 1–2)

T+3d ○ Operatie: open repositie, botplastiek en plaatosteosynthese (bron 2, p. 1)

T+6w ○ Polikliniek: goede stand, start gedeeltelijk belasten en fysiotherapie (bron 4, p. 1)

- T+3m ○ Polikliniek: consolidatie, volledig belasten (bron 4, p. 2)
- T+5m ○ Fysiotherapie tussenrapportage: flexie 110°, loopt zonder hulpmiddel (bron 5, p. 3)
- T+12m ○ Polikliniek: restklachten bij lang lopen, geen verdere behandeling (bron 4, p. 4)
- T+22m ○ Röntgen: geconsolideerd, restcongruentie 2 mm, gewrichtsspleet behouden (bron 6, p. 1)
- T+24m ○ Expertiseonderzoek

BRON

Bronnen 1, 2, 4, 5, 6

Hiaten in het dossier

○ DOSSIERORDENING

Fysiotherapie eindverslag

BELANGRIJK

Intake en tussenrapportage aanwezig (bron 5), maar geen afsluitend verslag.

VERWACHT T+8m · ACTIE Opgevraagd bij **ORGANISATIE-2**; niet ontvangen. Niet bepalend: het verdere beloop staat in de poliklinische brieven (bron 4).

1 Aard van het letsel en diagnose

● ARTS

Anamnese, medische gegevens, onderzoek en diagnose.

Anamnese

Betrokkene vertelt dat hij van een trap viel en met gestrekt rechterbeen neerkwam. Hij werd geopereerd en liep enkele maanden met krukken. Nu heeft hij pijn aan de buitenzijde van de rechter knie na ongeveer een uur lopen en bij traplopen met gewicht. Hurken en knielen lukken slecht. Hij werkt weer volledig, maar vermijdt werk in geknielde houding. Geen pijnstillers; de plaat zit er nog.

Medische gegevens

Laterale tibiaplateafractuur rechts, behandeld met open repositie en plaatosteosynthese op T+3d. Volledig belasten vanaf T+3m, fysiotherapie tot ongeveer T+8m. De röntgenfoto op T+22m toont een geconsolideerde fractuur met een restincongruentie van het gewrichtsvlak van 2 mm; de gewrichtsspleet is behouden.

UIT HET DOSSIER

Bronnen 1, 2, 4 en 6.

Onderzoek

Loopt zonder hulpmiddel, zonder duidelijk manken. Rustig litteken van 14 cm aan de buitenzijde van de rechter knie. Geen hydrops. Lichte drukpijn over de laterale gewrichtsspleet, zonder zwelling of crepitaties. Stabiel bij Lachman en bij varus- en valgusstress. Klinisch geen asafwijking. Meetwaarden in de tabel.

Meetprotocol

Actieve bewegingsuitslag in rugligging, gemeten met een goniometer volgens de neutraalnulmethode, drie keer per richting; vermeld is de hoogste waarde. Passief geen verdere uitslag. Omtrek met meetlint op vaste afstand van de bovenrand van de patella. Beide zijden in dezelfde volgorde gemeten. De metingen waren reproduceerbaar: per richting minder dan 5° verschil.

Diagnose

Lichte flexiebeperking en belastingspijn van de rechter knie bij een geconsolideerde laterale tibiaplateafractuur met een restincongruentie van het gewrichtsvlak van 2 mm.

METING	RECHTS (AANGEDAAN)	LINKS (CONTRALATERALE VERGELIJKING)	ALGEMENE REFERENTIE*	KLINISCHE DUIDING	GRADE MODIFIER (AMA 6E DRUK)
Extensie-flexie	0-0-120	0-0-140	0-0-135	lichte flexiebeperking	1 (licht)
Omtrek bovenbeen, 10 cm boven patella	49,5 cm	51,0 cm	—	1,5 cm atrofie	1 (1,0–1,9 cm)
Omtrek knie, midden patella	40,0 cm	39,5 cm	—	geen hydrops	—
Stabiliteit	stabiel	stabiel	—	geen instabiliteit	0
Stand (klinisch)	neutraal	neutraal	—	geen asafwijking	0

* Algemene referentiewaarde uitsluitend ter klinische oriëntatie; zij vormt geen zelfstandige classificatie. De linkerzijde is een contralaterale vergelijking, geen referentie. Grade modifiers volgens tabel 16-7 van de AMA Guides, 6e druk.

2 Relatie met het ongeval

● ARTS

Is de huidige afwijking medisch het gevolg van het ongeval?

De bewegingsbeperking en de belastingspijn zijn medisch aannemelijk gerelateerd aan de tibiaplateaufractuur en de behandeling daarvan.

DE ONDERZOEKEND ARTS

Conclusie

Op basis van het letselmechanisme, het gedocumenteerde beloop en het huidige onderzoek acht ik de bewegingsbeperking en de belastingspijn medisch aannemelijk gerelateerd aan de tibiaplateaufractuur en de behandeling daarvan.

Basis

De fractuur is op de ongevalsdag met CT vastgesteld. De klachten zijn sindsdien consistent beschreven en passen bij de restincongruentie van het laterale gewrichtsvlak. Voor een oorzaak buiten het ongeval zijn geen aanwijzingen.

UIT HET DOSSIER

Bronnen 1, 4 en 6.

Onzekerheid

Door de restincongruentie bestaat op lange termijn een verhoogd risico op artrose van het laterale compartiment. Dat is een risico, geen huidige afwijking, en telt niet mee in de huidige beoordeling.

Buiten mijn vakgebied

Niet van toepassing.

3

Toestand vóór het ongeval

● ARTS

Klachten, objectieve afwijkingen en functieverlies vóór het ongeval.

Klachten

In de huisartsinformatie over vijf jaar voor het ongeval zijn geen knieklachten gedocumenteerd.

UIT HET DOSSIER

Bron 7, p. 1-2.

Objectieve afwijkingen en functieverlies

Op de CT van de ongevalsdag zijn geen aanwijzingen voor bestaande artrose. De linker knie is bij onderzoek normaal.

UIT HET DOSSIER

Bron 1, p. 2.

Conclusie

Er zijn geen aanwijzingen voor voorafbestaande invaliditeit van het rechterbeen.

4

Medische eindsituatie

● ARTS

Is de eindsituatie bereikt, en zo nee, wanneer?

Oordeel

Gelet op de tijd sinds het ongeval, de behandeling, het huidige klinisch onderzoek en de beschikbare controle-informatie acht ik de orthopedische toestand stationair. De medische eindsituatie wordt vastgesteld per T+24m.

Basis

De fractuur is geconsolideerd. Sinds de polikliniek op T+12m zijn klachten en bevindingen gelijk gebleven, en er is geen verdere behandeling gepland.

UIT HET DOSSIER

Bron 4, p. 4; bron 6, p. 1.

Onzekerheid

Het verwijderen van de plaat, als dat later gebeurt, verandert het functieverlies naar verwachting niet wezenlijk.

5

Blijvende invaliditeit

● ARTS

Volgens de maatstaf in de polis, met aftrek van voorafbestaande invaliditeit.

Oordeel

19% functieverlies van het rechterbeen volgens de AMA Guides, 6e druk: klasse 2 voor een tibiaplateafractuur met ten hoogste 2 mm stapvorming (tabel 16-3), na correctie voor functionele historie, lichamelijk en aanvullend onderzoek. Er is geen voorafbestaande invaliditeit om in mindering te brengen.

Toepassing van de polis

De omzetting naar een uitkeringspercentage volgens de polis is aan de verzekeraar.

6

Overige opmerkingen

● ARTS

Opmerkingen

Geen.



ONDERDEEL

Verantwoording

Procedure en rolverdeling

○ DOSSIERORDENING

Opdracht	Opdrachtbrief OPDRACHTGEVER met vragen van de verzekeraar
Machtiging	Getekende machtiging van betrokkene
Dossierordening	Kinetic: ordening, tijdlijn, bronverwijzingen en hiaten, zonder medische duiding
Onderzoek	Anamnese en lichamelijk onderzoek door ARTS , basisarts, onder supervisie van de specialist
Verificatie en eindverantwoordelijkheid	De ondertekenend specialist heeft betrokkene zelf gezien op T+24m, de relevante orthopedische bevindingen geverifieerd en draagt de eindverantwoordelijkheid voor diagnose, beschouwing en conclusies
Verzekeraar	Controleert vraagstelling, feitelijke gegevens en volledigheid; niet de medische inhoud
Richtlijn	NVMSR-richtlijn medisch specialistische rapportage 2024

Inzage en blokkeringsrecht

○ DOSSIERORDENING

Gewezen op recht	Bij het onderzoek, mondeling en schriftelijk
Concept toegezonden	T+24m, met termijn van twee weken
Reactie betrokkene	Geen correcties

Disclosure statement

[DOSSIERORDENING](#)

Specialist	Specialisme orthopedie, BIG BIG-NR ; werkzaam in ORGANISATIE-9
Onderzoekend arts	Basisarts, BIG BIG-NR ; in dienst van Kinetic
Ervaring als deskundige	Specialist: ruim twintig jaar orthopedisch chirurg, circa 50 expertises per jaar; onderzoekend arts: drie jaar ervaring met expertiseonderzoek
Nevenfuncties	Geen nevenfuncties met een relatie tot partijen in deze zaak
Belangenconflicten	Geen; geen eerdere behandelrelatie met betrokkene en geen financieel belang bij de uitkomst
Relatie met de verzekeraar	In de afgelopen twaalf maanden zes opdrachten van deze verzekeraar



Bronnenlijst

[DOSSIERORDENING](#)

NR.	DOCUMENT	BRON	DATUM	PAG.
1	SEH-verslag met CT rechter knie	ORGANISATIE-1	T±0	1-2
2	Operatieverslag plaatosteosynthese	ORGANISATIE-1	T+3d	1
3	Ontslagbrief	ORGANISATIE-1	T+6d	1
4	Poliklinische brieven orthopedie	ORGANISATIE-1	T+6w-T+12m	1-4
5	Fysiotherapie intake en tussenrapportage	ORGANISATIE-2	T+2m-T+5m	1-3
6	Röntgenverslag controle beide knieën	Radiologie ORGANISATIE-1	T+22m	1
7	Huisartsjournaal	ORGANISATIE-3	T-5j-T+24m	1-2
8	AAOS Lower Limb-vragenlijst	Ingevuld door betrokkene	T+24m	1-2